颈腰椎退行性病 ★★★（0~4题）

腰椎间盘突出症

腰痛（窦椎神经）+下肢放射痛（坐骨神经），腰部活动受限尤其前屈，腰椎侧凸“内奸外患”（2018）

损伤平面判断（2007、2009、2010、2013、2024）
“L4L5S1 伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射，4- 股四头肌 - 伸膝、自己摸”

	运动障碍	感觉障碍	深反射障碍
L4	伸膝	膝前、小腿前内、内踝	膝反射
L5	伸踝、伸足	小腿外前、足背内	
S1	屈踝、屈足	小腿后、足外、外踝	踝 / 跟腱反射

膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型：无神经根受压→直腿抬高 (-) 及加强 (-)，保守治疗“紧箍不许摸不许碰”（2009、2010、2021）

突出型、脱出型、游离型：有神经根受压→直腿抬高 (+) 及加强 (+)，保守治疗→无效手术（2013）
但二便障碍（马尾神经受压）急诊手术（2019）

鉴别诊断
- 急性腰扭伤
  梨状肌综合征
  → 直腿抬高 (+) 及加强 (-)
  “急粒来不及加强”
- 腰椎间盘膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型
  慢性腰肌劳损
  第三腰椎横突综合征
  腰椎管狭窄：症状多体征少、神经源性间歇性跛行（2019、2022）
  → 直腿抬高 (-) 及加强 (-)